

■ DATOS SINTÉTICOS - SOLO PARA PRUEBAS - NO ES PACIENTE REAL ■

Este documento fue generado automáticamente para el desarrollo del clinical-extractor de SICA. No contiene PHI ni representa una paciente real. Cualquier semejanza con un caso clínico real es coincidencia.

HISTORIA CLÍNICA OBSTÉTRICA

Centro Materno-Infantil (sintético) — Consultorio Obstétrico

FILIACIÓN

Nombre:	PACIENTE SINTÉTICA - NO REAL
Edad:	31 años
Estado civil:	Casada
Ocupación:	Enfermera
Fecha de elaboración:	22/01/2026

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

Fórmula obstétrica: G1 P0. Primigesta. Antecedente de 2 episodios de ITU en últimos 12 meses (pregestacional).

GESTACIÓN ACTUAL

FUM:	05/10/2025
FPP:	12/07/2026
EG actual (por FUM):	16 semanas
Controles prenatales:	3 al momento
Diagnóstico:	Infección urinaria sintomática

Paciente refiere disuria, polaquiuria y urgencia miccional desde hace 4 días. Lumbalgia leve bilateral. Niega fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos. Movimientos fetales aún no percibidos. Sin signos de irritación uterina.

EXAMEN FÍSICO ACTUAL

PA 112/70 mmHg. FC 82 lpm. T° 36.8°C (afebril). Peso 60.5 kg. Puño-percusión lumbar negativa bilateral. Sin signos de pielonefritis. AU 14 cm. LCF 156 lpm.

LABORATORIOS (22/01/2026)

Analito	Resultado	Unidad	Observación
Hemoglobina	12.0	g/dL	Dentro de rango
Leucocitos	9400	/mm ³	Normal
PCR	1.2	mg/dL	Discretamente elevada
Examen de orina	Leucocitos 30-40/c	—	Piuria significativa
Urocultivo	E. coli >100,000	UFC/mL	Crecimiento significativo
Antibiograma	Sensible nitrofur.	—	Resistente a TMP-SMX

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

1. Embarazo de 16 semanas por FUM. 2. ITU baja sintomática (cistitis aguda) por E. coli. 3. Sin signos clínicos de pielonefritis aguda.

PLAN

1. Nitrofurantoína 100 mg VO c/8 h por 7 días (sensible según antibiograma, categoría B en gestación, evitar cerca del término). 2. Hidratación abundante (>2 L/día). 3. Educación sobre signos de alarma (fiebre, vómitos, dolor lumbar severo). 4. Urocultivo de control 7-10 días post-tratamiento. 5. Profilaxis con dosis baja si recurrencia. 6. Control prenatal regular en 2 semanas.